TOME 07 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Médecine Interne

Collège National des Enseignants de Médecine Interne (CEMI) • 286 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 07 : Médecine Interne.

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 286 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Collège National des Enseignants de Médecine Interne (CEMI).
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	286 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 07

Collège National des Enseignants de Médecine Interne (CEMI) • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 07 • Médecine Interne (286 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

- Chapitre 01 : Fièvre prolongée (190)
- Chapitre 02 : Splénomégalie (275)
- Chapitre 03 : Adénopathies superficielles (220)
- Chapitre 04 : Purpura (215)
- Chapitre 05 : Pathologies auto-immunes (192)
- Chapitre 06 : Lupus systémique et SAPL (194)
- Chapitre 07 : Neutropénie fébrile (191, 296)
- Chapitre 08 : Réaction inflammatoire (185)
- Chapitre 09 : Déficits immunitaires (189)
- Chapitre 10 : Vascularites systémiques (193)
- Chapitre 11 : Horton et Takayasu (195)
- Chapitre 12 : Acrosyndromes (239)
- Chapitre 13 : Pathologies du fer (219)
- Chapitre 14 : Sarcoïdose (211)
- Chapitre 15 : Biothérapies, Thérapies ciblées (202)
- Chapitre 16 : AINS (330)
- Chapitre 17 : Corticoïdes (330)
- Chapitre 01 — Fièvre prolongée (190)
- Diagnostic étiologique d’une fièvre prolongée
- Bilan paraclinique devant une fièvre prolongée (tombé en annale)
- Focus sur autres causes de fièvre prolongée
- Maladie de Whipple
- QCM
- • Maladie de Whipple peut être responsable d'une amylose AA
- • Polyarthrite avec sérologie négative de Facteur rhumatoïde
- • T. Whipplei a un tropisme essentiellement monocytaire et macrophagique
- • Contamination probablement oro-fécale mais il n'existe pas de transmission interhumaine

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

Chapitre 01 : Fièvre prolongée (190)
Chapitre 02 : Splénomégalie (275)
Chapitre 03 : Adénopathies superficielles (220)
Chapitre 04 : Purpura (215)
Chapitre 05 : Pathologies auto-immunes (192)
Chapitre 06 : Lupus systémique et SAPL (194)
Chapitre 07 : Neutropénie fébrile (191, 296)
Chapitre 08 : Réaction inflammatoire (185)
Chapitre 09 : Déficits immunitaires (189)
Chapitre 10 : Vascularites systémiques (193)
Chapitre 11 : Horton et Takayasu (195)
Chapitre 12 : Acrosyndromes (239)
Chapitre 13 : Pathologies du fer (219)
Chapitre 14 : Sarcoïdose (211)
Chapitre 15 : Biothérapies, Thérapies ciblées (202)
Chapitre 16 : AINS (330)

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Médecine Interne

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Définition	Fièvre prolongée sur un sujet sans terrain particulier, est définie par 3 critères : - T° ≥ 38,3 °C à plusieurs reprises : au repos, à distance des repas, par voie axillaire ou buccale en ajoutant +0,5°C - Dure depuis ≥ 3 semaines - Sans cause identifiée, malgré investigations appropriées (pas de liste pré-établie de ces investigations) : -> Soit après 3 consultations -> Soit durant 3 jours d'hospitalisation
Adaptation	Définition doit être néanmoins adaptée à la situation clinique (ex. T° à 38°C avec un syndrome inflammatoire persistant, sera pris en charge comme une fièvre prolongée)

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Médecine Interne

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Biologie	- Bilan standard : NFS, CRP, Ionogramme, Créatinine, Bilan hépatique, Bilan d'hémostase - Électrophorèse des protéines sériques - Calcémie, Ferritine, TSHus, LDH, Créatine kinase (CK) - AC anti-nucléaires (AAN), Facteur rhumatoïde, ANCA
Microbiologie	- Hémocultures x3 avant toute ATB - ECBU - IDR (intradermoréaction à la tuberculine) - Sérologies EBV, CMV, VIH ± toxoplasmose
Imagerie	- RXT + Échographie abdomino-pelvienne : au minimum - TDM-TAP avec injection : le plus souvent prescrit à la place des 2 autres - TDM des sinus, panoramique dentaire, mammographie, ETT : selon le contexte
CAT si négatif	1. Bilan de 2nd intention guidé par le contexte, la clinique et les premiers résultats d'examens 2. TEP-TDM au 18FDG : si absence d'orientation diagnostique 3. En l'absence de diagnostic final, le pronostic d'une fièvre prolongée est généralement bon 4. Si au bout de la démarche diagnostique nous n'avons pas de diagnostic formel, un traitement d'épreuve peut être discuté dans des cas exceptionnels où le pronostic vital est en cause (corticothérapie, un traitement anti-tuberculeux chez le sujet à risque ...)

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 07

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 07 • Médecine Interne (286 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Collège National des Enseignants de Médecine Interne (CEMI)
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (286 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.